جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : نجيه على السيد بدران
المحافظة : الشرقيه **الحي / المدينة :** بلبيس **العنوان :** //
رقم البطاقة : 25709301301328 **رقم التليفون :** 01006135750 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 09-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 30-09-1957 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: نجيه على السيد بدران
National ID: 25709301301328

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	**بشأن تقرير طبي للمريض**
بقسم:	**رقم طبي:**

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

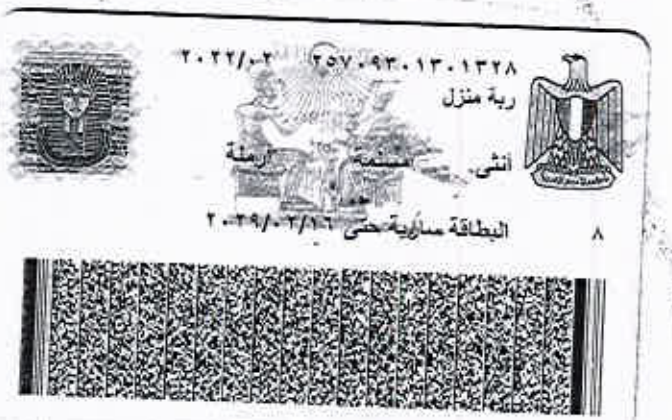
تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	**تاريخ وساعة الخروج :** PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي **Further investigations and imaging**

التاريخ : **05-07-2026**	**الوقت :** -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين





National ID – Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

Patient Name	: (الأسكلة / نجوى على السيد بدران)	Request No.	: 13006808
Patient No.	: 257093013013328	Request Date	: 24/02/2022
Path No.	: 533/2022	Verification Date	: 08/03/2022
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 64 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc :		Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data:
Right breast mass. Post neoadjuvent chemotharapy.

Nature of the specimen:
Right mastectomy & axillary clearance .

Gross Examination:
Right breast: 19x17x6 cm. with skin covering, 26x19 cm. Nipple was unremarkable. Axilla: 6x5 cm. Cut section revealed UOQ ill defined firm grayish white tumor bed site: 3.5x2x1.5 cm. Located 1.5 cm away from deep margin and 2cm away from skin . Axillary fat dissection revealed 14 nodules. Largest measured 2x2 cm in diameter.

Microscopic examination:
- Histological type: Invasive duct carcinoma
- Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): G II
- Angioinvasion: Positive.
- Ductal carcinoma in situ: No .
- Lymph node involvement: Positive metastatic deposits in 2/13 nodes with extracapsular extension.
- Resection Margins: Free .
- Histologic response to therapy: Partial Pathological response.

Diagnosis: .
Right mastectomy & axillary clearance:
Invasive duct carcinoma, GII
Partial Pathological response. 35% Tumor necrosis index.
Positive lymphovascular emboli.
Negative perineural invasion.

Verified by :
Dr.Marwa mahmoud

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

PATIENT NAME: **NAJEYAH ALI ELSAYYED BADARAN** GENDER: **Female** AGE: 64 y	PATIENT ID #: **2021166661** ORDER #: **1245839,1245840** DATE OF SERVICE: **02-Oct-2021 04:28 PM**

Report: - all studies

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN AND PELVIS

1-CHEST

- Multiple irregular spiculated heterogeneously enhancing mass lesions altered seen scattered within right breast associated with diffuse parenchymal distortion with the largest mass is seen measuring about 2.3x 4.4 cm.
- Multiple pathologically enlarged right axillary (level I and II) lymph nodes measuring up to 1.5x 1.7 cm.
- Right lower lobe apical segment subpleural pulmonary branching micro-nodule is seen likely inflammatory.
- Middle lobar thick atelectatic band.
- No CT evidence of pathologically enlarged hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- No gross cardiac abnormality. No pericardial effusion detected.
- Enlarged right thyroid lobe harboring few hypodense subcentimetric nodules.

2- ABDOMEN AND PELVIS

- Mildly enlarged liver with homogenous CT texture. No focal lesions or intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Patent homogeneously enhancing portal vein and is main branches as well as its main tributaries.
- Right renal lower calyceal dense stone is seen measuring 4 mm with no related back pressure changes.
- A 3 cm right renal cortical cyst is also noted.
- Left adrenal gland subcentimetric (7.5 mm) fat containing lesion is seen likely myelolipoma.
- Normal appearance of the pancreas, spleen, left kidney, right adrenal, aorta, I.V.C and the pelvic organs.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

- No pathologically enlarged abdominal or pelvic lymph nodes.
- No abdominal or pelvic masses or collections.
- The revised bone window revealed:

1. No CT evidence of vertebral collapse or extra-osseous soft tissue component.
2. Dorsolumbar spondylosis.

OPINION:

- Right breast masses with ipsilateral axillary lymphadenopathy.
- Right lower lobe apical segment subpleural pulmonary branching micro-nodule likely inflammatory.
- No definite hepatic or osseous metastatic deposits.

Reported By,

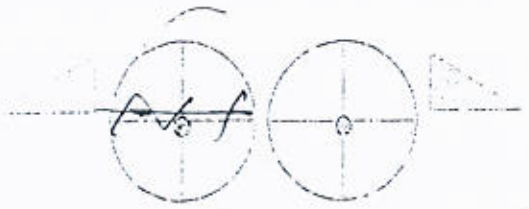
Dr. Amr Farouk ,MD
Dr. Ghada Hamed Khalifa,MSc **03-Oct-2021 03:12 PM**

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

MDT FORM

10/3/2022

Name	نجيبة علي السيد
Age	٤٣٨٤ / ٤٠٤١
MRN	
ID	٢٩٠١٢٠١٢٥٨
Phone	٤٢٨٤١٤٠٤١
Co morbidities	٠١٠٠٦١٢٥٧٠٠



T N M

Clinical Data

IDC

8/8
5/8
+ve

Rt breast Cancer, post NACT, post Rt MRM
Invasive ductal Carcinoma
partial pathological respones
35% of tumour. Necrosis index

MDT OUTCOME & PLAN

L.Ns 2/13 C partial pathological Respns
YPT2 YPN1
- For. PORT - Kadayla. R- 14 cycles.
- AI 15y + palabam.
-

SIGNATURE			
MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY

10.3.22

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]